F4 Ängste, Zwänge, dissoziative Störungen

Impuls im Rahmen der Prüfungsvorbereitung

Tim Weyrauch

Neurotische Störungen

- Angststörungen: objekt-, situationsgebundene oder frei flottierende Ängste
- Zwangsstörungen: Zwangsgedanken und Zwangshandlungen
- Dissoziative Störungen: körperliche Beschwerden bestimmen das Krankheitsbild

Ängste - Phobische Störungen F40.-

Eine Gruppe von Störungen, bei der Angst ausschließlich oder überwiegend durch eindeutig definierte, eigentlich ungefährliche Situationen hervorgerufen wird. In der Folge werden diese Situationen typischerweise vermieden oder mit Furcht ertragen.

- Herzklopfen, Schwächegefühl, sekundäre Ängste: Sterben, Kontrollverlust, wahnsinnig werden.
- Vorstellung erzeugt Erwartungsangst.
- Häufig komorbid mit F32.
- F40.0 **Agoraphobie** Befürchtungen, das 🏠 zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in 👥 und auf öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit 🚆, 🚌 oder ✈️ zu reisen. Eine Panikstörung kommt als häufiges Merkmal bei gegenwärtigen oder zurückliegenden Episoden vor. (20-30 Lj)
- F40.1 **Soziale Phobien** Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zu Vermeidung sozialer Situationen führt. Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik verbunden. Sie können sich in Beschwerden wie 😟, 🤲zittern, 🤢 oder Drang zum 🚽 äußern. Manchmal hält die Person eine Begleiterscheinung der Angst für das Hauptproblem. Kann sich bis zu Panikattacken steigern. (14-25 Lj)
- F40.2 **Spezifische (isolierte) Phobien** auf eng umschriebene Situationen wie Nähe von bestimmten 🐍🐀🐕, ⛰️, 🌪️, 🌑, ✈️, geschlossene Räume 🚪, 🚽 oder 💩 auf öffentlichen Toiletten, Genuss bestimmter 🍲, 🦷🔪 oder auf den Anblick von 🩸 oder 😵 beschränkt sind. Obwohl die auslösende Situation streng begrenzt ist, kann sie Panikzustände wie bei Agoraphobie oder sozialer Phobie hervorrufen. (meist Kindheit, bei Erwachsenen zumeist Chronifizierung)

Ängste – Andere Angststörungen F41.-

Bei diesen Störungen stellen Manifestationen der Angst die Hauptsymptome dar, ohne auf eine bestimmte Umgebungssituation bezogen zu sein.

- Depressive und Zwangssymptome, sogar einige Elemente phobischer Angst können sekundär vorhanden sein.
- F41.0 **Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst)** Nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränkt, daher vorhersehbar. Herzklopfen 💗, Brustschmerz, Erstickungsgefühle 😮‍💨, Schwindel 🌀, Depersonalisation/-realisation. Nicht Hauptdiagnose wenn F32. (20-30 Lj)
- F41.1 **Generalisierte Angststörung** "frei flottierend". Die wesentlichen Symptome sind variabel, Beschwerden wie ständige Nervosität 😬, Zittern, Muskelspannung 💪, Schwitzen 💦, Benommenheit 😵, Herzklopfen 💗, Schwindelgefühle 🌀 oder Oberbauchbeschwerden 🤢 gehören zu diesem Bild. Häufig wird die Befürchtung geäußert, der Patient selbst oder ein Angehöriger könnten demnächst erkranken 🥴 oder einen Unfall haben 🚑. ~~(15-25 Lj)~~ (35-45 Lj)
- F41.2 **Angst und depressive Störung gemischt** Wenn Angst 😟 und Depression 😔 gleichzeitig bestehen, aber keine allein die Diagnose trägt; sind beide stark genug, stellt man beide Diagnosen getrennt.

Diagnostik / Komorbidität F40/41

- Erfragen der Symptomatik
- Ausschluss anderer psychiatrischer und organischer Erkrankungen
- Test:
  - SKID-I Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV
  - DIPS Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen
  - STAI State-Trait-Angst-Inventar
  - HAMA Hamilton-Angstskala
- Komorbidität
  - F1 Sucht und Substanzmissbrauch (SOS)
  - F32
  - F60.6 (Ängstlich vermeidende PS)
  - Im Akutfall auch an Flashbacks denken.

Zwangsstörungen F42.-

Stereotype Ideen , Vorstellungen oder Impulse . Sie sind fast immer quälend , Widerstand häufig erfolglos. Die Gedanken und Tätigkeiten werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, selbst wenn sie als unwillkürlich, sinnlos und ineffektiv und häufig abstoßend 🤮 empfunden werden. Zwangshandlungen oder -rituale sind Stereotypien, die ständig wiederholt werden.
Der Patient erlebt sie oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis , das ihm Schaden bringen oder bei dem er selbst Unheil anrichten könnte. Angst ist meist ständig vorhanden. Werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Angst deutlich 📈 .

- F42.0 **Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang** 🤯 🔄 Diese können die Form von zwanghaften Ideen 💡 , bildhaften Vorstellungen 🖼️ oder Zwangsimpulsen ⚡ annehmen, die fast immer für die betreffende Person quälend sind. Manchmal sind diese Ideen eine endlose Überlegung unabwägbarer Alternativen, häufig verbunden mit der Unfähigkeit, einfache, aber notwendige Entscheidungen des täglichen Lebens 🛒 🏠 zu treffen. Die Beziehung zwischen Grübelzwängen und Depression 😔 ist besonders eng. Eine Zwangsstörung ist nur dann zu diagnostizieren, wenn der Grübelzwang nicht während einer depressiven Episode auftritt und anhält.

- F42.1 **Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]** Bezieht sich meist auf Reinlichkeit 🧼 (Händewaschen 🧼 🤲), wiederholte Kontrollen 🔄 🔍 , die garantieren, dass sich eine möglicherweise gefährliche Situation nicht entwickeln kann, oder übertriebene Ordnung 📏 📦 und Sauberkeit 🫧 . Diesem Verhalten liegt die Furcht vor einer Gefahr 🚨 zugrunde, die den Patienten bedroht oder von ihm ausgeht; das Ritual ist ein wirkungsloser oder symbolischer Versuch 🔮 , diese Gefahr abzuwenden.

Diagnostik / Komorbidität F42

- Über einen Zeitraum von 2 Wochen bestehen an den meisten Tagen folgende Symptome:
  - Zwangsgedanken/impulse müssen vom Patienten als seine eigenen erkannt werden (Ich-dyston)
  - Widerstand gegen min. einen Zwang
  - Unangenehm
  - Wiederholung in unangenehmer Weise
  - HZI Hamburger Zwanginventar
- Zwanghaftigkeit wird bei F1 und F42 und bei Zwangssymptomen bei F20 (hier gab es Diskussion) als Ich dyston erlebt
  - Bei Wahnsymptomen von F20 (hier gab es Diskussion), F63 (St. d. Impulskontrolle) und der F60.5 (Zwanghafte und anankastische PS) als Ich-synton

Dissoziative (Konversions-) Störungen F44.-

Teilweise/völliger Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. Die Symptome verkörpern häufig das Konzept der betroffenen Person, wie sich eine körperliche Krankheit manifestieren müsste. Körperliche Untersuchung und Befragungen geben keinen Hinweis auf eine bekannte somatische oder neurologische Krankheit. Funktionsverlust Ausdruck emotionaler Konflikte oder Bedürfnisse. Die Symptome können sich in enger Beziehung zu psychischer Belastung entwickeln und erscheinen oft plötzlich.

- F44.0 **Dissoziative Amnesie** Verlust der Erinnerung für meist wichtige aktuelle Ereignisse 🗓️ wo eine übliche Vergesslichkeit 🤔 oder Ermüdung 🛌 als Erklärung nicht ausreicht. Die Amnesie bezieht sich meist auf traumatische Ereignisse 💥 wie Unfälle 🚑 oder unerwartete Trauerfälle und ist in der Regel unvollständig und selektiv.
- F44.1 **Dissoziative Fugue** 🧳 🏞️ Eine zielgerichtete Ortsveränderung 🚶 , die über die gewöhnliche Alltagsmobilität hinausgeht. Inkl. F44.0.
- F44.2 **Dissoziativer Stupor** 🪨 Beträchtliche Verringerung oder des Fehlens von willkürlichen Bewegungen 🚫 🦵 und normalen Reaktionen auf äußere Reize wie Licht 💡 , Geräusche 🔊 oder Berührung 🖐️
- F44.3 **Trance- und Besessenheitszustände** 🌀 Zeitweiliger Verlust der persönlichen Identität und der vollständigen Wahrnehmung der Umgebung auf.
- F44.4 **Dissoziative Bewegungsstörungen** 🦵 Vollständiger oder teilweise Verlust der Bewegungsfähigkeit eines oder mehrerer Körperglieder. Sie haben große Ähnlichkeit mit fast jeder Form von Ataxie, Apraxie, Akinesie, Aphonie, Dysarthrie, Dyskinesie, Anfällen oder Lähmungen.
- F44.5 **Dissoziative Krampfanfälle** Ähneln epileptischen Anfällen bezüglich ihrer Bewegungen. Zungenbiss 👅 , Verletzungen beim Sturz 🤯 oder Urininkontinenz 💧 sind jedoch selten. Ohne Bewusstseinsverlust stattdessen manchmal ein stupor- oder tranceähnlicher Zustand 🌀 .
- F44.6 **Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen** 🖐️ 🧊 verschiedener Körperareale. Es kann auch unterschiedliche Ausfälle der sensorischen Modalitäten geben. Sensorische Ausfälle können von Klagen über Parästhesien ✨ begleitet sein.

Dissoziative Identitätsstörungen F44.81

Verschiedene Persönlichkeitszustände (dissoziative Identitäten) übernehmen abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen. Aus dieser Sicht verfügen solche Identitäten über eigene Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Wahrnehmungs- und Denkmuster und werden daher auch als Zeichen Struktureller Dissoziation betrachtet. Zusätzlich würden Erinnerungslücken zu Ereignissen oder persönlichen Informationen auftreten, die nicht mehr durch gewöhnliche Vergesslichkeit erklärbar sind

Ganser-Syndrom F44.80

Vorbeiantworten: Krankheitsbild bei dem die meist jüngeren männlichen Patienten falsch antworten. Es wird auch als „Pseudodebilität“ oder „hysterischer Dämmerzustand“ bezeichnet und gehört zu einer Reihe klinischer Bilder, die unter dem umstrittenen Oberbegriff „Pseudodemenz“ zusammengefasst werden.

Dissoziative (Konversions-) Störungen F44.-

- Neigt zur Remission, besonders wenn der Beginn mit einem traumatisierenden Lebensereignis verbunden ist. Chronisch eher bei unlösbaren Problemen oder interpersonalen Schwierigkeiten.
- Körperliche Untersuchung und Befragungen geben keinen Hinweis auf eine bekannte somatische oder neurologische Krankheit. Funktionsverlust Ausdruck emotionaler Konflikte oder Bedürfnisse.
- Nur Störungen der körperlichen Funktionen, die normalerweise unter willentlicher Kontrolle stehen, und Verlust der sinnlichen Wahrnehmung sind hier eingeschlossen. Störungen mit Schmerz und anderen komplexen körperlichen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden, sind unter Somatisierungsstörungen (F45.0) zu klassifizieren. Die Möglichkeit eines späteren Auftretens ernsthafter körperlicher oder psychiatrischer Störungen muss immer mitbedacht werden.
- Die Diagnose sollte nicht bei hirnorganischen Störungen 🧬, Intoxikationen 🍷 💊 oder extremer Erschöpfung 😩 gestellt werden.
- Hier sind nur Trancezustände 🧘 zu klassifizieren, die unfreiwillig oder ungewollt sind, und die außerhalb von religiösen 🙏 oder kulturell akzeptierten Situationen auftreten.
- Vollständige Seh- oder Hörverluste bei dissoziativen Störungen sind selten.

Quellen

1. Ofenstein, M. (2023). Prüfungswesen Heilpraktiker für Psychotherapie. 3. Auflage.

Hauptquelle für Definitionen, diagnostische Kriterien und prüfungsrelevante Zusammenfassungen.

ICD-Code.de ICD-10 Diagnosekatalog – F40, F41, F42, F44.

Verfügbar unter: [https://www.icd-code.de/icd/code/ (Abruf: September 2025).

Wikipedia. (o. J.). *Artikel zu Ganser-Syndrom*.

Verfügbar unter: [https://de.wikipedia.org/] (Abruf: September 2025).